2023학년도 내과 학년말고사 (231107)

* 60분 시험(CBT)

총 **60문항** 중 **60문항** 복기.

총평: 전반적으로 탈야마 했던 시험입니다. 90점 넘는 사람이 없었던 꽤나 어려웠던 시험이었습니다. 학년말고사 야마나 계통 야마에서도 안 나온 새로운 문제들이 많이 출제되었습니다.

[심장내과] (10문항) 야마에서 많이 나오던 소재 위주로 출제 되었음. 탈야마한 문제도 기본적인 내용 위주로 출제하심.

[호흡기내과] (10문항) 탈야마 했는데 계통에서 나오던 문제도 있었는데 생소한 문제도 많았음.

[소화기내과] (10문항) 그나마 야마를 타는 편이었는데 탈야마한 문제들도 많았음.

[신장내과] (10문항) 그나마 야마를 좀 탔음. 박준성 교수님 계통 야마를 많이 내신듯.

[감염내과] (5문항) 야마도 타고 탈야마한 문제도 답 고르는 것은 어렵지 않았음.

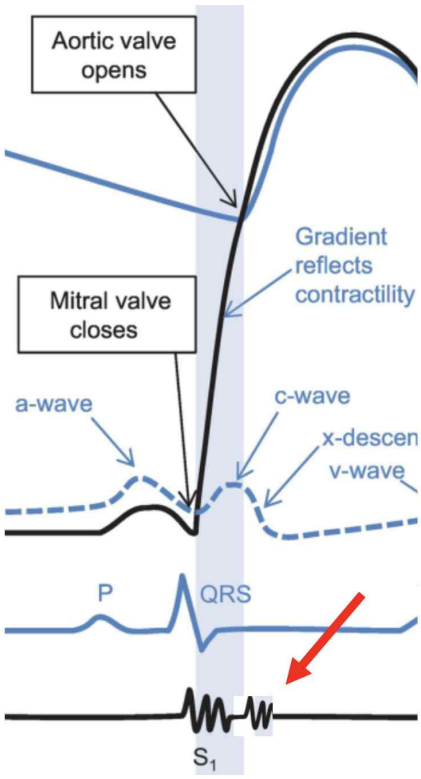
[혈액종양내과] (5문항) 완전 새로운 문제 스타일로 출제되었음.

[내분비내과] (5문항) 그나마 야마 가장 많이 탔음. 가장 무난.

[류마티스내과] (5문항) 출제되던 소재 위주로 나옴. 어렵지 않았음.

[심장내과] 10문항

1. 다음 화살표가 나타내는 심음이 나타날 수 있을 때는?



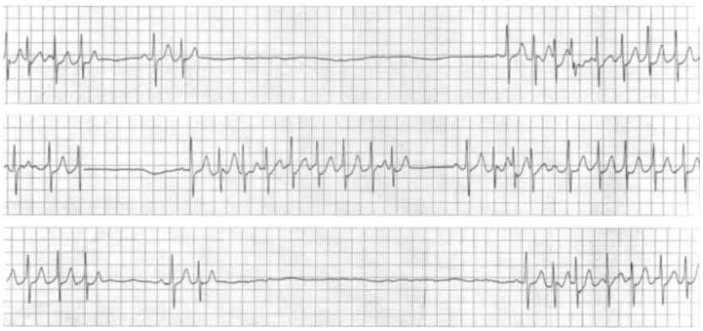
① 폐동맥판협착
② 대동맥판 염증
③ 승모판 역류
④ 승모판 협착
⑤ 삼첨판 파열

2. 82세 남성이 70년 동안 담배 피고 술 먹었는데 하지의 위약감으로 내원하였다. 걸을 때마다 아파서 평소에 등산을 즐겼으나 최근에는 하지 못했다. 당뇨랑 고혈압이 있었고, vital sign이 혈압이 150/90이었고 호흡이랑 맥박, 체온은 정상이었다. ABI 시행하였고 오른쪽 1.01, 왼쪽 0.61이었으며, CT angio 사진은 다음과 같았음. 시행할 수 있는 처치는?



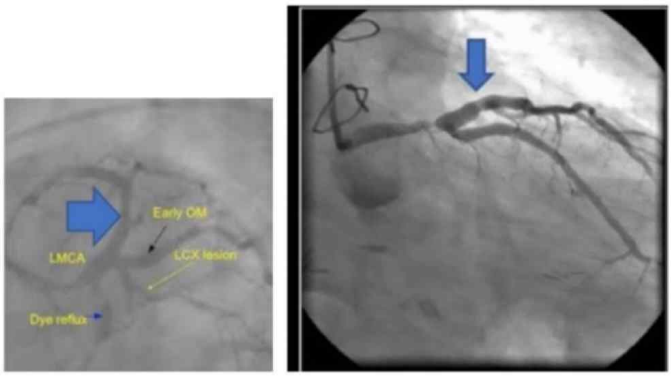
① 경피적혈관개통술
② (나머지는 절대 안 고를 것 같은 선지들)

3. 66세 남성이 앉아 있다가 갑작스런 의식 소실로 응급실에 내원하였다. 환자의 vital sign은 다음과 같았다.
혈압 95/70 - 맥박 95 - 호흡수 22 - 체온 36.4
심전도를 촬영했을 때 다음 그림과 같았다고 할 때, 의식 소실의 이유는 무엇인가?



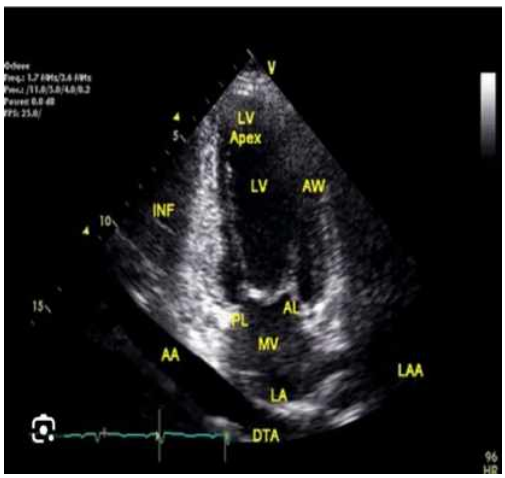
① Tachycardia-bradycardia syndrome
② 1도 방실차단
③ 2도 방실차단
④ 3도 방실차단
⑤ 발작성 상심실성 빈맥

4. 70세 남성이 가슴을 쥐어짜는 듯한 흉통으로 내원하였다. CAG (spider view, caudal view)를 다음과 같이 촬영하였을 때, 화살표로 표시되어 있는 혈관의 이름은?



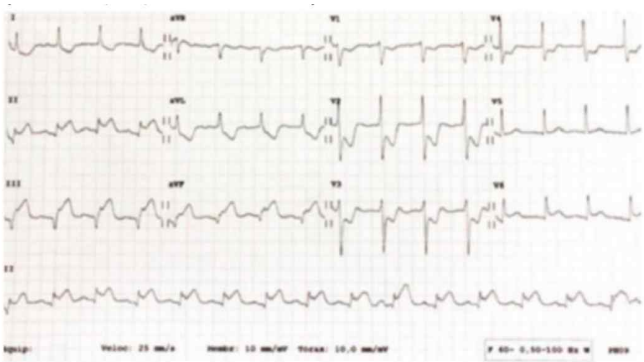
① Left anterior descending artery
② Left main coronary artery
③ Left circumflex artery
④ Right anterior descending artery
① Posterior descending artery

5. 66세 여성이 호흡곤란 및 실신을 호소하며 내원하였다. 혈압은155/62였으며, 우측 제2늑간에서 수축기 심잡음이 들렸다. 심초음파를 실시하였으며, peak velocity 4.6m/s였고, pressure gradient 53이었다. 심초음파는 2 chamber view였고, aorta 쪽으로 나가는 axis가 그어짐. EF은 63%였을 때, 다음 환자의 진단명은 무엇인가? (도플러 초음파도 주어졌음)



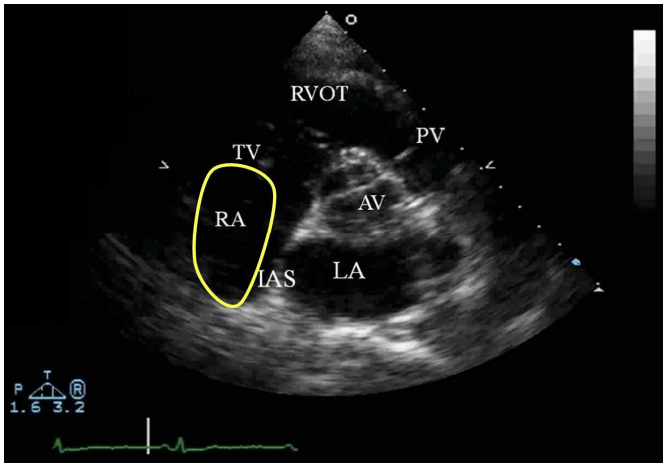
① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ HFrEF

6. 가슴의 통증으로 내원한 66세 남성이다. CAG 시행하였고, RCA total occlusion으로 PCI 시행하였다. (CAG 사진 주어졌음) 남성의 심전도는 다음과 같았다. 이 남성에서 앞으로의 합병증을 예방하기 위해 1년 동안 투여해야 하는 것은?



① 항혈소판제
② 항응고제
③ BB
④ Digoxin
⑤ ARB

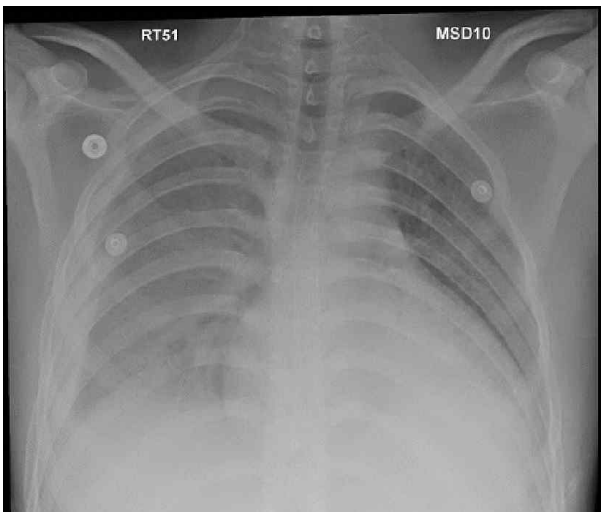
7. 다음 심초음파에서 노란색으로 표시된 구조물의 이름은?



① 우심방
② 우심실
③ 좌심방
④ 좌심실
⑤ 상대정맥

8. 82세 여자 숨이 차서 내원, 집에서 화장실만 걸어가도 숨이 참, 혈압150/110mmHg, 맥박128회, EKG, CXR 사진 주어짐. 심초음파 상 finding: EF=35%, 좌심방 비대, 우심방 비대 나타남. 이 환자에게 생존율을 개선할 수 있는 약제는?





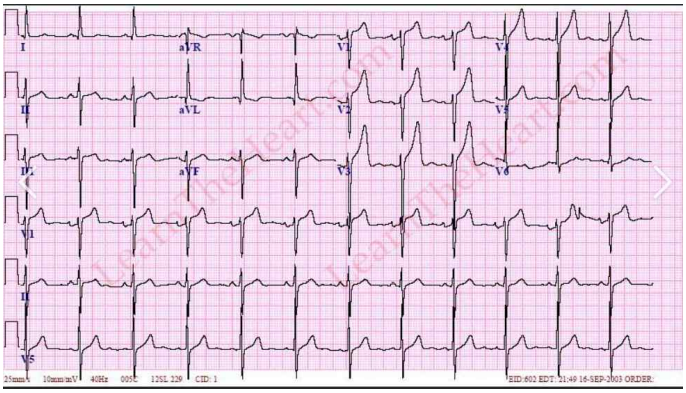
① Furosemide
② Amiodarone
③ Thiazide
④ Carvedilol
⑤ Heparin

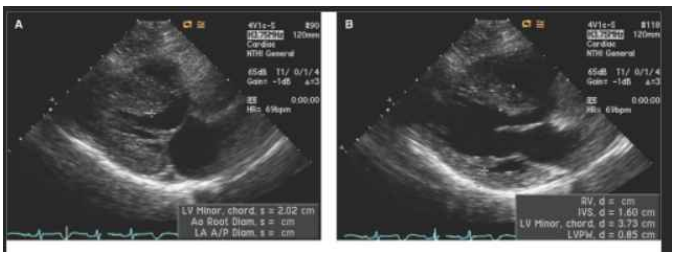
9. 41세 남자가 점점 조여오는 흉통으로 내원하였다. 20년 동안 흡연하였고, 심전도 상으로 ST elevation을 나타내고 있었다. 이 환자의 CAG 시행 결과가 다음의 사진과 같을 때, 시행해야 할 것으로 올바른 것은?



① 경피적관상동맥성형술

10. 18세 남학생이 체육시간에 축구를 하던 중 심정지로 119 통해 내원하게 되었다. 적절한 심폐소생술 이후에 진행한 work-up에서 다음과 같은 finding이 있었다. EKG (LVH라고 조그맣게 써 있었음) 이 남학생의 급사 예방을 위하여 필요한 추가 조치는?





① Carvedilol
② Heparin
③ Digoxin
④ Pacemaker
⑤ ICD

[호흡기내과] 10문항

11. 19세 남자 3년 전부터 지속되는 콧물과 재채기로 일상생활에 지장 있어 내원하였다. 피부 단자 시험 결과는 아래와 같다. 이 때 원인 항원에 대한 탈감작을 위해 시행할 수 있는 치료는?

집먼지진드기 8mm
꽃가루 2mm
히스타민 5mm
바퀴벌레 0mm
생리식염수 0mm

① 항히스타민제
② 항 IgE 치료
③ 봄철 야외활동 피하기
④ 면역치료
⑤ 스테로이드

12. 82세 여성. 며칠 전부터 호흡곤란과 피가래 있었음. 5년 전부터 허리가 아팠고 저번 달부터는 심해져 거의 누워서만 지내고 있었음. 이틀 전에 가슴 아프다가 이젠 괜찮음. 심음과 호흡음 정상, 흉부 엑스선 정상, 오른 종아리 부어있었음. 앞으로 시행해야 할 검사 중 먼저 할 검사로 적절한 것은?
① 뇌 MRI
② 흉부 조영증강 CT
③ 하지 조영증강 CT
④ 하지 X-ray
⑤ D-dimer 검사
※ 답 논란 ②⑤

13. 부폐렴성 흉수에서, 흉관을 삽입하여 적극적으로 배액해야 하는 경우에 해당하는 것은?
① Empyema
② 흉수 Gram negative 균 확인
③ 흉수 Glucose < 720 mg/dL
④ Bilateral pleural effusion
⑤ Comorbid liver disease

14. 37세 남성 기침과 고열로 내원하였다. 기저 질환 없고, 내원하여 찍은 CXR 및 CT 사진은 다음과 같다.
(cavitary lesion이 보이는 CXR, Tree-in-bud sign 보이는 chest CT 사진 제시됨.)
가장 먼저 시행해야 하는 검사는?
① 가래 항산균 도말
② 가래 세균 배양검사
③ 폐렴구균 뇨항원 검사
④ 혈청 마이코플라즈마 항체
⑤ 혈액 세균 배양검사

15. 발열과 숨이 찬 증상으로 내원한 33세 남성. X-ray Left decubitus view에서 2.5cm가 확인되었다. 흉수 확인된 환자. 시행해야 하는 검사? (흉수 차 있는 X-ray 사진 2장 주어짐)



① Chest CT
② Chest PET-CT
③ Chest MRI
④ Fine needle biopsy
⑤ Thoracentesis & Pleural fluid analysis

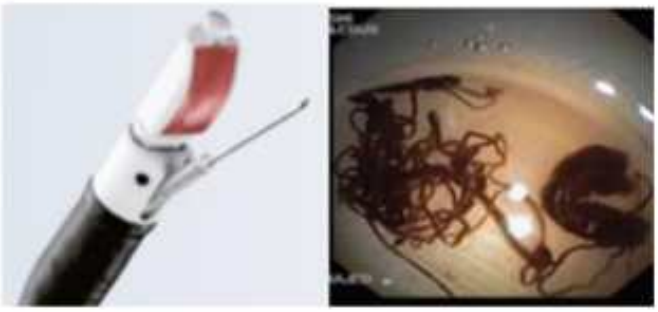
16. 발열과 숨이 찬 증상으로 내원한 26세 여성. 흉수천자 시행하였고, 흉수 분석 결과 단핵구성 삼출액이 확인되었다. 이 때 다음으로 시행해야 할 검사는? (흉수 차 있는 X-ray 사진 2장 주어짐)



① Adenosine deaminase (ADA)
② 말초혈액 호산구 수
③ PET-CT
④ 심장초음파
⑤ 흉수배양검사

17. (야마 변형) 다음 중 폐암의 병기 설정을 위해 필요한 검사가 아닌 것은?
① 척수 MRI
② 뇌 MRI
③ PET-CT
④ 복부 CT
⑤ 전신 뼈스캔

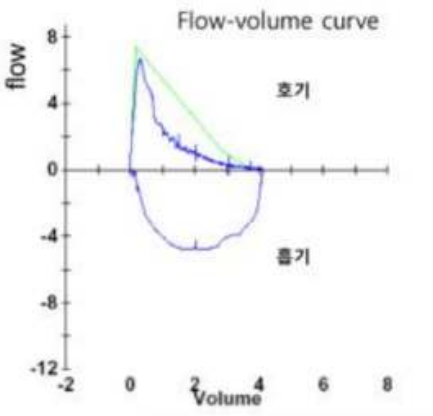
18. (계통 Y) 60 대 남성이 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 다음은 CT, PET-CT 검사결과이다. (carina 주변에서 hypermetabolic한 LN 3 군데 보임) 그리고 시행한 검사에서 사용한 기구와 채취한 검체의 육안적 소견 사진을 보았을 때, 이 검사의 이름은?



① Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA)
② Electromagnetic Navigational Bronchoscopy (ENB)
③ Autofluorescence Bronchoscopy(AFB)
④ Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)

19. (야마) 천식을 진단받고 저용량 흡입 스테로이드 사용 중인 환자이다. 최근 일주일에 2번 이상 낮에 증상이 심해지고 밤에 자다가 깨기도 하며, 일상 생활에 지장이 많다. 흡입제는 매일 1회 사용 중이다. 환자에게 필요한 치료는?
① 저용량 흡입스테로이드와 지속성 베타 2 효현제
② 저용량 흡입스테로이드
③ 경구 스테로이드
④ 테오필린
⑤ 속효성 베타 2 효현제

20. 61세 남성. 3개월 전부터 시작된 호흡곤란을 주소로 내원. 폐기능 검사 결과 아래와 같다. 진단은? (강의록에서 발췌함. 시험은 실제 사진)



① COPD
② 폐렴
③ IPF
④ 기흉

[소화기내과] 10문항

21. (학년말 Y 변형) 50세 남성이 2주 전부터 배가 불러온다며 병원에 왔다. 매일 소주 1병씩 먹었다. 혈압 140/90mmHg 외 V/S 정상. 의식은 명료하다. 배는 팽만하고 둔탁음이 있다. 배에 압통은 있으나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 혈액요소질소 20 mg/dL, 크레아티닌 1.3 mg/dL, 총단백질 3.9 g/dL, 알부민 1.2 g/dL 복수: 총단백질 3.1 g/dL, 백혈구 700/mm^3 (중성구 10%, 림프구 75%, 단핵구 15%), 아데노신탈아미노효소(ADA) 90 U/L, 결핵균 중합효소연쇄반응 음성

① 버드키아리증후군
② 알코올성 간경변
③ 췌장염
④ 복막 암종증
⑤ 결핵성 복막염
※ Pulmonary TB가 아닌 경우 PCR의 민감도, 특이도는 떨어진다고 합니다. 그에 비해 ADA의 민감도는 굉장히 높습니다.

22. (학년말 Y) 46세 남성이 8일 전 고열과 우상복부 통증이 있어 병원에 내원하였고 담낭 절제술과 경피 배액술을 받았다. 수술 후 배액줄에서 250ml 의 갈색 담즙이 계속 나왔으며 우상복부 복통과 반발압통이 지속되어 ERCP를 시행하였고 조영제가 수술부위에서 새는 것을 발견하였다. 적절한 처치는?

V/S: 38.3℃ , 나머지는 정상범위 Lab: total protein, albumin, LFT(AST, ALT, GGT, total bilirubin) 모두 정상, CRP 상승

① 내시경온쓸개관스텐트삽입술
② 온쓸개관T자관삽입술
③ 온쓸개관 절제술
④ 내시경 경화술
⑤ 경과관찰

23. (학년말 Y) 57세 남성이 붉은 피를 토해 내원하였다. 평소 하루에 소주 한 병을 마시던 환자였다.

BP-80/46, HR-122, RR-18, BT- 37.1 Hb-8.2, INR-1.8, GGT-1,110 (이외 lab 이상소견 없었음)

먼저 시행해야 할 처치는?
① Telipressin
② 내시경적 지혈술
③ 예방적 항생제
④ 수혈
⑤ 정맥 식염수 투여

24. (학년말 Y) 72세 여자가 2시간 전부터 계속 혈변을 본다고 응급실에 왔다. 어지럽다고 하고 식은땀을 흘리고 있다. 당뇨병과 고혈압으로 아스피린을 복용하고 있다. 혈압 70/50mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.2℃이다. 피부는 창백하고 장음은 증가되어 들린다. 명치부위에 압통이 있지만 반동압통은 없다. 직장손가락 검사에서 덩이는 만져지지 않고 붉은 피가 묻는다. 0.9% 식염수 1리터를 급속 정맥주사 한 후 혈압은 100/70mmHg이다. 검사는?
① 상부위장관내시경
② 대장내시경
③ 대장조영술
④ 캡슐내시경
⑤ 위창자간막동맥 조영술

25. (탈 Y) 80세 남성이 수주 전부터 시작된 연하곤란과 가슴통증을 주소로 내원하였다. 하루에 한 갑씩 60년간 흡연하였고 매일 소주 1병씩 먹었다. 건강검진 결과 하부식도암(Squamous cell carcinoma, stage T3N1M0) 으로 진단되었다. 다음 설명 중 옳은 보기는?
① 가장 흔하게 발생하는 동시성 암은 폐암이다.
② 가장 흔한 발생 원인은 역류성 식도염이다.
③ 임상적으로 국소 진행암에 해당한다.
④ 초음파 내시경으로 M staging을 진행한다.
⑤ 근치적 복합항암화학요법으로 치료한다. (방사선 이란 단어 없었음)

26. (탈 Y) 32세 여성 변비를 주소로 내원하였다. 변은 1주일에 2회 정도 보았고, 염소똥처럼 나왔다고 한다. 복통도 동반되었고, 변 본 후 완화되었다고 한다. 다음 설명 중 옳은 보기는?

대장내시경, 복부 CT: 이상 x Lab: 모두 정상

① 궤양성 대장염이다.
② 과민성 장 질환 설사형에 해당한다.
③ 과민성 장 질환 변비형이므로 식이섬유가 풍부한 식사를 권장한다.
④ 과민성 장 질환 설사형 치료 관련 보기

27. (탈 Y) 30대 여성이 혈변을 주소로 내원하였다. 변을 볼 때 항문 통증이 있었고, 선홍색의 피가 휴지와 변기에 조금 묻어 나왔다. 직장 수지 검사에서는 이상이 없었다. 복부 X-ray 및 CT 검사에서도 이상 소견 발견되지 않았다. 올바른 진단은?
① 치핵
② 궤양성 대장염
③ 대장 게실
④ 대장암

28. (한양대 임종평 Y 변형) 76세 여자가 2시간 전부터 못 참을 정도로 배가 아파 병원에 왔다. 수 개월 전부터 골관절염으로 비스테로이드소염제를 복용하였으며, 공복 시 속쓰림이 있었다. 복부 전체에 복통과 반발 압통이 있었고 판자 같은 딱딱함이 관찰된다. 검사는?
① 대장내시경
② 식도내압검사
③ 복부 초음파 검사
④ 상부위장관 내시경
⑤ 복부 컴퓨터 단층 촬영

29. (한양대 임종평 Y) 70세 남자가 건강검진 목적의 위내시경 검사를 시행하였다. 검사는?



① 생검
② 복부 초음파
③ 초음파 내시경
④ 복부 자기공명영상
⑤ 양전자 방출 단층 촬영 (PET)

30. (한양대 임종평Y) 51세 남자가 속쓰림으로 왔다. 한 달 전 흑변을 보았으나 현재는 정상 변을 본다고 한다. 상부위장관내시경 검사 (그림1) 및 신속요소분해효소 검사(그림2)를 시행하였다. 처치는?

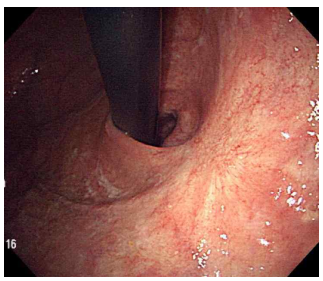


그림 1



그림 2

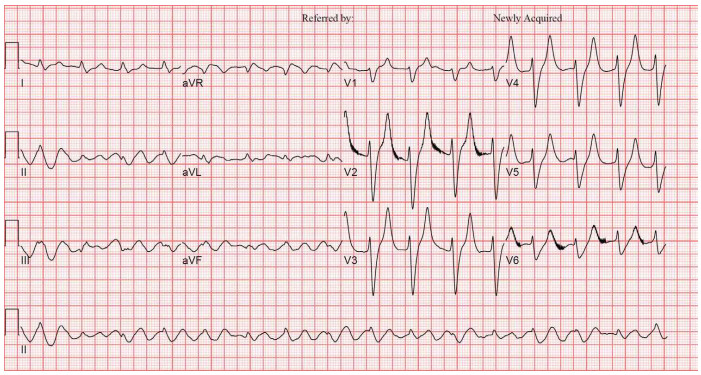
① 경과 관찰
② 내시경 지혈술
③ 프로톤펌프억제제 투약
④ 헬리코박터 파일로리 제균치료
⑤ 3개월 이내 상부위장관내시경 검사 재시행

[신장내과] 10문항

31. 만성신부전 4기 환자에게 권장하는 식단은?
① 고칼륨식이
② 고염분식이
③ 고단백식이
④ 고인산식이
⑤ 모두 아님

32. 62세 남성이 당뇨병의 병력이 있다. 최근 호흡곤란이 심해져서 내원하였고 신장내과로 협진을 의뢰받았다. eGFR=45, 혈당 8.3%이었고, X-ray에서 심비대가 뚜렷하게 관찰되었으며, EF=43%이었다. 이 환자에게 사용할 수 있는 당뇨병 약물로 옳은 것은?
① Glucagon like peptide 1 agonist
② Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor
③ SGLT2 inhibitor
④ Sulfonylurea
⑤ Insulin

33. 64세 여성. 만성신부전 5기 환자인데 투석 거부하고 약제 치료만 하고 있다. 피로해서 내원 예정일보다 일찍 내원하였다. 평소에 배고파서 토마토를 자주 갈아먹었다고 한다. 소변량이 감소했고, 호흡곤란은 없었지만 힘들고 기력이 없어 내원하였다. EKG 소견이 다음과 같을 때, 이 환자에서 가장 의심되는 전해질 문제는 무엇인가?



① Hyperkalemia
② Hypercalcemia
③ Hyponatremia
① Hypochloremia

34. 45세 당뇨를 진단 받았던 남성이 56세에 proliferative retinopathy로 안과에 내원하였다가 신장 내과로 협진을 의뢰받았다. 이 환자에서 보일 것으로 생각되는 소견은?
① 사구체 기저막의 비후
② Protein 4500mg/g
③ 전반적인 사구체 경화
④ GFR 160mL/min/1.73m^2
⑤ 전신부종이 심해서 이뇨제를 사용해야 한다.

35. 26세여성 IgA nephropathy. ARB 복용중이었음. 단백뇨 수치가 2460mg/gCr이었다가 600mg/gCr으로 호전되었다. 추가로 단백뇨 감소시키기 위해 쓸 수 있는 약제는?
① SGLT2 inhibitor
② ARNI (Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor)
③ ACE inhibitor
④ Loop diuretics
⑤ Finerenone

36. 27세 여성이 간헐적 하지경련으로 내원했다. 혈압은 120/80, serum Na/K/Cl/HCO3- 135/2/100/40, pH 7.5으로 확인되었다. 최근 구토나 이뇨제 복용력은 없었고, 출생 시에는 특이소견이 없었다고 했다. Urine Na/K/Cl 120/45/50, Urine Ca/Cr 0.1이었다. 검사결과가 다음과 같을 때 환자에게서 나타날 소견으로 옳은 것은?
① Hearing deficiency
② Pitting edema (+/+)
③ BP 150/90mmHg
④ Urine normal prostaglandin E2
⑤ Urine output > 3000ml/day

37. 63세 남성이 고혈압을 주소로 내원했다. 18개월 동안 감초가 들어간 한약제를 지속적으로 복용하였다. 검사 결과는 다음과 같다. 어떤 수용체가 활성화되어 고혈압이 발생한 것인지 고르시오.

혈청 Na 140 K+ 2.0mEq/L, Cl normal Plasma renin activity < 0.1ng/mL/hr Aldosterone 1.91

① ENaC (Epithelial Sodium channel)
② NCC (Sodium Chloride Cotransporter)
③ NKCC2 (Na+/K+/Cl- cotransporter 2)
④ NHE3 (Sodium - hydrogen antiporter 3)
⑤ SGLT2 (Sodium-Glucose Cotransporter 2)

38. 66세 남자가 악화된 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 6개월 전부터 양측 하지의 부종 시작되었으며 2주 전부터 전신부종으로의 진행 및 호흡 곤란이 악화되어 내원하였다. 검사는 다음과 같을 때 가장 적절한 진단은?

anti-phospholipidase 2 antibody (+) 나머지 항체 검사 정상, ASO/보체 정상.

① Membranous glomerulonephritis
② Poststreptococcal glomerulonephritis
③ Membranoproliferative glomerulonephritis
④ Lupus nephritis
⑤ Thin basement membrane nephropathy

39. 20대 여자가 다뇨로 내원하였다. 1년 전 당뇨로 진단받고 약물 복용중이며 최근에 다이어트 한다고 물을 하루에 3L씩 마셨다고 한다. 다뇨의 감별진단을 위한 검사로 가장 중요한 것은?
① 24h urine test
② water restriction test
③ 혈청나트륨과 오스몰
④ ADH level
⑤ Minirin 주고 소변량 검사

40. 상습적으로 요로감염이 있는 여성에게서 감염을 예방할 수 있는 생활습관 원칙이 아닌 것은?
① 비데를 이용하여 청결하게 씻는다
② 공용목욕탕 사용 이후 배뇨한다.
③ 소변, 대변을 뒤로 닦는다
④ 물을 많이 마신다
⑤ 소변을 참지 않는다

[감염내과] 5문항

41. 실습 시작 전 면역력을 확인하거나 백신 접종을 통해 면역력을 확보해야 하는 것이 아닌 것은?
① HAV
② HBV
③ HCV
④ Measles
⑤ Varicella

42. 다음 중 손위생을 해야 하는 시점이 아닌 것은?
① 무균 처치 전
② 환자 접촉 전
③ 환자 접촉 후
④ 환자 주변 접촉 전
⑤ 체액 노출 위험 술기 후

43. 다음 중 공기매개주의에 사용해야 하는 것은?
(5가지 다 사진으로 나옴)
① 일회용 가운
② 외과 마스크
③ 투명 비닐 장갑
④ N95 마스크
⑤ 페이스 쉴드

44. 다음에 관한 설명으로 옳은 것은?

※ 강의록에 없는 항생제 내성 표 주어졌음. 중요한 부분: ESBL(+), ~penem 2가지 (S), PIP/TAZ (S)

① 사용 가능한 항생제는 carbapenem 뿐이다.
② ESBL 생성균이다.
③ 14일간 사용한다.

45. 요로감염으로 입원한 환자가 항생제 사용하여 호전되다가, 7일 후 다시 발열 생겼다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
① 항생제를 바꾼다.
② 새로운 병원감염을 고려해야 한다.
③ 소변검사 추적한다.
④ 현재 항생제 치료 유지한다.

[혈액종양내과] 5문항

46. 70세 여성이 어지러움과 피곤함을 주소로 병원에 내원하였다. WBC 3000, Hb 6.7, PLT 57000으로 범혈구감소증을 보였다. 골수 검사 상에서 다음과 같은 결과를 보였다. 해당 질환에 대한 설명으로 옳은 것은?

[골수 검사] cellularity 50%, megaloblast 11% RBC precursor에 megaloblast dysgranulogenesis, dysmegalogenesis Complex karyotype

① 환자의 생존율이 1년도 채 되지 않는다.
② 환자에 대해 자가 조혈 모세포 이식을 시행할 수 있다.
③ 이 환자에 대한 치료로 imatinib을 투여한다.
④ 환자 빈혈의 가장 흔한 원인은 철 결핍이다.

47. 65세 여성이 허리 통증으로 내원하였다. 검사 결과는 아래와 같았다. 환자의 질환을 진단하기 위해 추가로 시행해야 할 검사는?

WBC 5800 Hb 8.7 PLT 265K Total protein/albumin 9.3/3.3 BUN/sCr 20.9/3.2 Ca/P 11.4/4.6

① 혈청 단백질 전기영동 검사
② 골수 생검
③ 신생검
④ 전신 뼈 스캔

48. (DLBCL라고 진단명이 주어짐) 60세 이상, LDH 상승, 경부 및 서혜부 림프절 (+), Extranodal (-). EBV (-). 환자의 질환에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Anti-CD20을 포함하는 복합항암화학요법을 시행한다.

② IPSS Low risk에 해당한다.

③ 해당 유형은 호지킨림프종 중에서 가장 흔한 아형이다.

49. 암성 통증에 관련하여 옳은 설명은?

① 포괄적 통증의 원인에는 통증에 대한 환자의 지식 및 오해, 의료체계의 문제점 등도 포함된다.

② 지속 통증은 잘 조절되던 중 간헐적으로 악화되는 통증으로, 속효성 진통제에 의해 조절된다.

③ Somatic pain은 우리한 형태로 나타난다.

④ Codeine은 반감기가 길어서 통증 조절에 유리하다

50. 60세 여성이 최근에 시작된 dyspnea로 내원하였다. 위염으로 치료 받은 적이 있었다. 체중 감소는 없었다. 혈액검사 소견은 아래와 같다. 추가로 진행해야 할 검사는?

WBC 5400 Hb 7.6 PLT 298K MCV 56fl, ferritin 30

① 대장내시경 검사

② 골수 검사

③ 말초혈액 도말검사

④ 단백질 전기영동 검사

⑤ 심초음파검사

[내분비내과] 5문항

51. 34세 여자 환자로 Hashimoto's Thyroidits로 진단 받고 Levothyroxine 100mcg 처방 받아 매일 공복 식전에 꾸준히 복용하고 있는 상태이다. 검사 결과상 TSH 1.22μIU/mL, Free T4 1.7ng/dL(0.8~1.68)이다. 앞으로의 치료 계획은?

① 현재 복용량 유지

② Levothyroxine 12.5mcg 증량

③ Levothyroxine 25mcg 증량

④ Levothyroxine 12.5mcg 감량

⑤ Levothyroxine 25mcg 증량

52. 20대 남자의 경구당부하 검사 결과이다. 진단명은?

75g OGTT 0분 110 mg/dL, 120분 154 mg/dL HbA1c 6.0%

① Impaired glucose tolerance

② Impaired fasting glucose

③ Impaired glucose tolerance + Impaired fasting glucose

④ 정상

⑤ 당뇨병

53. 요양원에서 지내는 81세 남자 환자, ?과 전신쇠약감으로 내원하였다. 내원 3일 전부터 기침, 가래, 발열 시작되어 식사를 잘하지 못해 혈당강하제도 복용하지 못하였다. 내원 당시의 Vital sign 이다. 90/65 mmHg, HR 111 /min, RR 17 /min, BT 38.8°C. 현재 흉부 청진상 심음은 정상이며 우하엽에서 기관지 호흡음, 흡기 시 수포음이 들린다. 의식 상태는 부르면 대답은 하는 상태이다. 검사 결과는 아래와 같다.

ABGA pH 7.38, PO2 90 mmHg, PCO2 35 mmHg, HCO3- 20 mEq/L CBC WBC 22,300 Hb 15.4 PLT 350,000 Na/K/Cl 125?아무튼 낮음/4.7/? Glucose 900대, HbA1c 13.8% BUN/Cr 55/1.6 Protein/Albumin 7.0/2.9? Ca/P 7.8/2.5? U/A protein (-) glucose 4+ ketone (-)

가장 먼저 해야하는 처치는?

① 중탄산나트륨 정맥 투여

② 칼륨 정맥 투여

③ 등장성 생리식염수 정맥 투여

④ 항생제 투여

⑤ 속효성 인슐린 정맥 투여

54. 64세 남자. 15년 전 당뇨, 고혈압 진단 받고 약물치료 받는 중임. 키 170 cm에 몸무게 52 kg로 4개월동안 체중 8 kg 감소됨. 검사 결과는 다음과 같다.
Glucose 465, HbA1c 13% (이거 외로 검사 결과 한 4줄 정도 있었음... severe anemia 도 있었던 것 같음.)
현재 비경관영양 시도하려는데 다음 중 감소하였을 때 영양요구량을 증가시킬 수 있는 인자는?

① 신장

② 체중

③ 나이

④ 신체활동량

⑤ 신체스트레스

55. 70세 여자가 골밀도 검사를 위해 병원에 왔다. 골밀도 소견은 다음과 같다. 이에 대한 적절한 해석과 진단은?

	Z score	T score
L1	-2.5	-2.9
L2	-2.4	-2.7
L3	-2.3	-2.5
L4	-2.1	-2.3
Femur neck	-2.3	기억 안나지만 L1~L4 평균이 더 작은 값
Femur total	-2.1	

① T score -2.6, Osteoporosis

②~⑤: 틀린 Z/T-score/osteopenia or osteoporosis 조합들로 구성된 선지

[류마티스 내과] 5문항

56. 35 세 여성 환자가 관절통을 주소로 내원하였다. 6 년 전부터 양측 손목에 통증이 있어왔으며, 2 개월 전부터 양측 손목의 통증과 부종, 오른쪽 팔목의 부종, 오른쪽 2번째 MCP의 통증을 느끼기 시작하였다. 혈액검사 결과가 다음과 같을 때, 환자에게 추가로 시행해야 할 검사는?

CBC Hb 12.6, WBC 9200, Platelet 17500, ESR 40 CRP 3.7, ANA (-)

① ACPA
② ANA
③ ANCA
④ 항Sm항체
⑤ 항이중가닥DNA항체

57. Bamboo spine X-ray 21세 남성이 허리통증이 6개월 전부터 있었다. 조조강직 (+), 검사 결과 ESR 40, CRP 4.0 등으로 나타났다. 이 환자의 초기 치료 약물로 가장 적절한 것은?
① Corticosteroid
② Anti-TNFα inhibitor
③ NSAID
④ Sulfasalazine
⑤ Methotrexate

58. 48세 남성이 5개월 전부터 지속되는 발목의 통증으로 내원했다. 검사 결과 Hb 12.6, WBC 9200, ESR 36, CRP 9, Creatinine 3.0 최근 통증이 심해졌는데, 이와 같은 급성기 증상을 치료하기 위한 약물로 적절한 것은?
① 콜히친(colchicine)
② 나프록센(naproxen)
③ 메토트렉세이트(methotrexate)
④ 아세타미노펜(acetaminophen)
⑤ 글루코코르티코이드(glucocorticoid)

59. 28 세 남자가 오른쪽 발목 아래의 관절통 때문에 내원하였다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 있었으나 약물을 임의적으로 중단하였다. 5 일 전부터 오른쪽 엄지 발가락이 붓고 압통 있었다. 외상은 없었다. 3 개월 전에도 오른쪽 엄지 발가락의 압통 있었으나 5일 내 호전되었다. 이 환자에서 진단을 위해 가장 필요한 검사는?
① 관절액검사
② 관절초음파
③ 발 mri
④ 발 이중CT
⑤ 요산검사

60. 1년전부터 손목이 아팠으며, 3,4,5번 MCP가 아팠다. 아침에 일어나서 괜찮아질 때까지 2시간 이상 걸렸으며 입안에 궤양이 관찰되었다. 다른 피부증상은 없었다. 혈액검사 결과가 다음과 같을 때 가장 의심되는 진단명은 무엇인가?

ANA positive 1:40 speckled pattern CRP 10 ACPA negative RF 16 (정상수치 <15) Anti-dsDNA antibody negative

① 성인형 스틸병
② SLE
③ Bechet 병
④ 류마티스관절염
⑤ 척추성 관절염